Клинические рекомендации

Рак гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C32** — Злокачественное новообразование гортани **D38.0** — Гортани
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/475_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) 3

3. Диагностика **5**

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Осмотр и пальпация шеи 5

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией 5

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ 5

3.6 Лабораторные и морфологические исследования 5

4. Лечение **6**

4.1 Складочный отдел гортани 6

4.2 Надскладочный отдел гортани 6

4.3 Лучевая и лекарственная терапия 7

4.4 Медицинская реабилитация 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации **8**

5.1 Диспансерное наблюдение 8
5.2 Организация медицинской помощи 8
6. Источник и актуальность 9
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Рак гортани — злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия гортани. Основные симптомы — изменение тембра голоса, осиплость, поперхивания.
- Заподозрить рак: стойкая осиплость; кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения; затруднение дыхания; увеличение шейных лимфоузлов, образования на шее.
- Предопухолевые заболевания: хронический гиперпластический ларингит, пахидермия, лейкоплакия, дисплазия и гиперкератоз слизистой оболочки, полипы голосовых складок, папилломатоз гортани.
- Всем с подозрением на рак гортани — фиброларингоскопия с биопсией; при повторных неинформативных биопсиях — видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация — **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. **надскладочный отдел** — гортанная поверхность надгортанника (включая верхушку), черпалонадгортанные связки, черпаловидные хрящи и межчерпаловидная область, часть надгортанника ниже подъязычной кости, вестибулярные складки, гортанные желудочки
2. **складочный отдел** — голосовые складки, передняя и задняя комиссуры
3. **подскладочный отдел** — от нижней поверхности голосовых складок до уровня первого кольца трахеи

Голосовой протез — клапанное устройство для восстановления голоса, имплантируемое при трахеопищеводном шунтировании. Электрогортань — вибрирующий аппарат, прикладываемый к подбородку; голос металлический, без тембровой и эмоциональной окраски.

2.2 Этиология и эпидемиология

Факторы риска: длительное курение, алкоголь, запылённость (текстильное производство), канцерогены (нефть и продукты перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления — при папилломах (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующем папилломатозе, пахидермии, дискератозе, хронических ларингитах.

Заболеваемость в России в 2019 г. — 31,1 на 100 тыс. населения, летальность — 7,2%.

2.3 Клиническая картина

1. **вестибулярный (надскладочный) отдел** — на ранних стадиях может протекать бессимптомно; парестезия, сухость, ощущение инородного тела, неудобство при глотании; позже боль при глотании с иррадиацией в ухо, дисфагия, гнилостный запах, кровохарканье
2. **голосовой (складочный) отдел** — рано — охриплость, кашель, реже кровохарканье; при прогрессировании — стеноз, боль с иррадиацией в ухо, гнилостный запах
3. **подскладочный отдел** — раннее затруднение дыхания

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: складочный отдел гортани

T	Складочный отдел
T1	опухоль ограничена голосовыми связками, подвижность сохранена (может быть вовлечена передняя или задняя комиссура); T1a — одна связка, T1b — обе
T2	распространение на надсвязочную и (или) подсвязочную области с нарушением подвижности голосовых связок
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) прорастанием в надсвязочное пространство, небольшой эрозией щитовидного хряща
T4a / T4b	T4a — прорастание в щитовидный хрящ или ткани вокруг гортани (трахея, мягкие ткани шеи, мышцы языка, щитовидная железа, пищевод); T4b — предпозвоночное пространство, средостение, оболочка сонной артерии

Символ T: надскладочный отдел гортани

T	Надскладочный отдел
T1	ограничена одной анатомической областью надсвязочной части, подвижность голосовых связок сохранена
T2	несколько анатомических частей надсвязочной или связочной области либо вненадсвязочная часть (корень языка, валлекула, медиальная стенка грушевидного синуса) без фиксации гортани
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) распространением на преднадгортанную ткань, минимальная эрозия щитовидного хряща

Подскладочный отдел: T1 — ограничена подсвязочной частью; T2 — распространение на голосовые связки со свободной или ограниченной подвижностью; T3 — фиксация связок и (или) эрозия щитовидного хряща; T4a — прорастание в перстневидный или щитовидный хрящ, ткани вокруг гортани.

1. **N1** — метастаз в одном ипсилатеральном лимфоузле до 3 см без экстракапсулярной инвазии (ENE−)
2. **N2** — один ипсилатеральный до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных; с обеих сторон или контралатеральные до 6 см ENE−
3. **N3** — более 6 см ENE−; любой метастаз с ENE+ кроме N2a

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4 N0–N2 M0
IVB	T4b, любая N, M0; любая T, N3, M0
IVC	любая T, любая N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, пункция узлов шеи под УЗИ, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы, на которые обращают внимание

1. стойкое нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
2. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани;
3. постоянный кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
4. увеличение шейных лимфоузлов, образования на шее.

3.3 Осмотр и пальпация шеи

Признаки при осмотре

1. изменение контуров шеи;
2. увеличение регионарных лимфоузлов;
3. изменение подвижности и ширины остова гортани.

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией

Всем с подозрением на рак гортани — фиброларингоскопия с биопсией (патологоанатомическое исследование) и цитологией отпечатков и мазков для оценки распространённости и верификации опухоли.

При повторных неинформативных биопсиях и клинико-рентгенологических данных о злокачественном процессе — видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ

Всем при раке гортани — УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией подозрительных узлов.

При распространённом раке с поражением регионарных лимфоузлов — КТ органов грудной полости для выявления отдалённых метастазов.

При стадиях III–IV — ПЭТ-КТ с ФДГ для исключения отдалённых метастазов и оценки эффекта лечения, в том числе регрессии регионарных метастазов после лучевой или химиолучевой терапии.

При подозрении на распространение на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды — КТ или МРТ мягких тканей шеи и головного мозга с контрастированием; при подозрении на переход на гортаноглотку или пищевод перед ЛТ — МРТ шеи.

3.6 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет. При распространённых стадиях, не предусматривающих только локальное лечение, — экспрессия PD-L1 (TPS, CPS).

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение;
5. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Складочный отдел гортани

Лечение рака складочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
Tis (карцинома in situ)	эндоларингеальная резекция (предпочтительно CO_2-лазером) или ЛТ
T1–T2 N0	самостоятельная ЛТ или резекция гортани (эндоскопическая лазерная или открытая)
T1–T2 N+	конкурентная ХЛТ или резекция гортани с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией
T3 N0	конкурентная ХЛТ; индукционная ХТ для сохранения органа; ларингэктомия с гемитиреоидэктомией и паратрахеальной лимфодиссекцией
T3 N+	одномоментная ХЛТ; индукционная ХТ с последующей ХЛТ; ларингэктомия с шейной лимфаденэктомией
T4a, любая N	ларингэктомия с тиреоидэктомией, паратрахеальной и шейной лимфодиссекцией; при отказе от операции — ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ). Нет НПФ и pN0 — наблюдение.

1. **R1** — перезекция, при невозможности — ЛТ или ХЛТ
2. **1 НПФ (периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия)** — ЛТ
3. **2 и более НПФ, pN2** — ХЛТ
4. **ENE+** — конкурентная ХЛТ

1. **полная или частичная регрессия после индукционной ХТ** — ЛТ или ХЛТ
2. **стабилизация или регрессия менее 50%** — операция
3. **остаточная опухоль после ЛТ или ХЛТ** — операция
4. **полная регрессия** — динамическое наблюдение

Эффект ХЛТ оценивают не ранее чем через **2–3 месяца**.

1. **T4b, неоперабельные метастазы, M1 при ECOG 0–1** — лекарственная терапия (в отдельных случаях ХЛТ) или симптоматическое лечение
2. **ECOG 2** — лекарственная терапия
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.2 Надскладочный отдел гортани

Лечение рака надскладочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0–1	резекция гортани (эндоскопическая или открытая) с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при N0 — также самостоятельная ЛТ
T1–T2 N2–3	одномоментная ХЛТ, индукционная ХТ с ХЛТ или резекция гортани с шейной лимфодиссекцией
T3 N0–3	одномоментная ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ; ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией
T4a N0–3	ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией с послеоперационной ХЛТ; при отказе — ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

При раке надскладочного отдела без клинических признаков поражения лимфоузлов всем рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция II–IV уровней.

Удаление узлов II–V уровней

1. метастазы в лимфоузлах IV или V уровня;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. множественные метастазы более 3 см;
4. экстракапсулярное распространение;
5. регионарный рецидив.

1. **рецидив без предшествующей ЛТ** — операция при резектабельности; при ECOG 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; нерезектабельный при ECOG 2 — паллиативная ЛТ или лекарственная терапия
2. **рецидив после ЛТ** — операция при резектабельности с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ
3. **рецидив с отдалёнными метастазами** — ECOG 0–1 — лекарственная терапия; ECOG 2 — лекарственная; ECOG 3 — симптоматическое лечение

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Самостоятельная ЛТ: на опухоль и регионарные метастазы 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **6–7 недель**, на зоны регионарного метастазирования 44–63 Гр. При T1N0M0 голосового отдела возможно гипофракционирование 50–55 Гр.

При ХЛТ — 70 Гр за 7 недель; стандарт — цисплатин 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни ЛТ; альтернатива — карбоплатин или цетуксимаб (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ показана при pT3–4 и N0–1, у отдельных пациентов с pT1–2. Интервал после операции — **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**. Доза при R0 — 60 Гр, при R+ — 66 Гр.

Показания к послеоперационной ХЛТ

1. прорастание капсулы лимфоузла;
2. положительный край резекции при отказе от реоперации;
3. 2 и более неблагоприятных фактора.

Лекарственная терапия плоскоклеточного рака индивидуализируется: схемы на основе препаратов платины, фторурацила, таксанов и цетуксимаба; иммунотерапия ниволумабом или пембролизумабом (с учётом PD-L1); при ECOG 2 — монотерапия. Режимы и дозы — таблица 1 КР.

При местно-распространённом раке оценивают риск кровотечения (изъязвление, близость ветвей сонной артерии, состоявшееся кровотечение); при риске — ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

4.4 Медицинская реабилитация

До и в раннем послеоперационном периоде всем пациентам — логопедические занятия при дисфагии и обучение речи.

Методы восстановления голоса

1. пищеводный голос;
2. трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезом;
3. электронные голосообразующие аппараты (электрогортань).

Активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, на этапе заживления и при свищах.

Всем до начала лечения — профилактическая гимнастика и занятия при дисфагии для уменьшения нарушений глотания.

Всем — нутритивная поддержка **не менее 7 суток**. Показания перед операцией: потеря 10% массы за 6 месяцев, ИМТ менее 20, белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л, ухудшение питания за последнюю неделю.

При невозможности питаться через рот — назогастральный зонд (на срок **до 3–4 недель**) или гастростома.

Всем перед ЛТ или ХЛТ — консультация и сопровождение стоматолога; удаление зубов в облучённой зоне — только при необходимости и на фоне антибиотиков (риск лучевого остеомиелита).

Профилактика и лечение мукозита на фоне ХЛТ — низкоинтенсивная лазеротерапия; при болевом синдроме — консультация альголога.

На фоне лекарственной и химиолучевой терапии — лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление, тренировка баланса при полинейропатии).

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и осмотр, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. рентгенография грудной клетки каждые 12 месяцев, КТ и МРТ по показаниям;
4. ПЭТ-КТ после индукционной ХТ — **не ранее чем через 2–3 месяца**;
5. ТТГ каждые 6–12 месяцев (функция щитовидной железы).

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование — **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

1. **экстренная госпитализация** — осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение

Факторы прогноза

1. размер и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
5. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по тексту КР)
Код в рубрикаторе	475_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 «Группировка по стадиям» в стадии IVA указано «T4 N0, N1, N2», тогда как T4b относится к стадии IVB; в IVA должна входить только T4a.